사용상의주의사항
(주사제)

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

1) 이 약에 의하여 쇽의 병력이 있는 환자

2) 세팔로스포린계 항생물질에 과민반응 환자

3) 저체중출생아, 신생아, 영ㆍ유아, 소아(근육주사에 한함.)

4) 리도카인 등의 아닐리드계 국소마취제에 과민반응의 병력이 있는 환자(근육주사에 한함.)

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 이 약 또는 세펨계 항생물질에 과민반응의 병력이 있는 환자에는 투여하지 않는 것이 원칙이나 부득이 투여할 경우에는 신중히 투여한다.

2) 페니실린계 항생물질에 과민반응의 병력이 있는 환자

3) 본인 또는 부모, 형제가 기관지천식, 발진, 두드러기 등의 알레르기증상을 일으키기 쉬운 체질인 환자

4) 중증의 신장애 환자

5) 경구섭취가 불량한 환자 또는 비경구영양 환자, 고령자, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K 결핍증상이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰한다.)

3. 이상반응

1) 쇽 : 드물게 쇽을 일으킬 수 있으므로 충분히 관찰하고 불쾌감, 구내이상감, 천명, 어지러움, 변의, 이명, 발한 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

2) 과민반응 : 때때로 발진, 두드러기, 홍반, 가려움, 발열, 림프절 종창, 관절통 등이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

3) 피부 : 드물게 스티븐스-존슨증후군, 독성표피괴사용해가 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

4) 혈액계 : 때때로 빈혈, 과립구 감소, 적혈구 감소, 호산구 증가, 혈소판 감소 드물게 범혈구 감소, 용혈성 빈혈이 나타날 수 있으므로, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 한다.

5) 간장 : 때때로 AST, ALT, ALP의 상승 드물게 황달, LDH, γ-GTP상승 등이 나타날 수 있다.

6) 신장 : 드물게 급성 신부전 등의 중증의 신장애가 나타날 수 있으므로 정기적으로 검사를 실시하는 등 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

7) 소화기계 : 드물게 위막성대장염 등의 혈변을 수반하는 중증의 대장염이 나타날 수 있다. 복통, 빈번한 설사가 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 또한 때때로 구역, 설사 또한 드물게 구토, 식욕부진, 복통 등이 나타날 수 있다.

8) 호흡기계 : 드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부 X선 이상, 호산구 증가 등을 수반하는 간질성 폐렴, 호산구성 폐침윤 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 코르티코이드 투여 등 적절한 처치를 한다.

9) 중추신경계 : 신부전 환자에 대량 투여 시 경련 등을 일으킬 수 있다.

10) 균교대증 : 드물게 구내염, 칸디다증이 나타날 수 있다.

11) 비타민 결핍증 : 드물게 비타민 K 결핍증상(저프로트롬빈혈증, 출혈경향 등), 비타민 B군 결핍증상(설염, 구내염, 식욕부진, 신경염 등)이 나타날 수 있다.

12) 기타 : 드물게 어지러움, 두통, 권태감, 마비감이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다.

2) 쇽 등의 반응을 예측하기 위해 충분히 문진하고 사전에 피부반응시험을 실시하는 것이 바람직하다.

3) 쇽 발생에 대비하여 구급처치준비를 해두고 투여 후에도 환자를 안정한 상태에서 충분히 관찰한다.

4) 투여 중 정기적으로 임상검사(간기능, 신기능, 혈액 등)를 실시하는 것이 바람직하다.

5) 취급상의 주의 : 이 약의 주사액 조제시에 쇽을 수반하는 접촉성 두드러기가 나타나는 경우가 있으므로 조제시의 손의 종창, 소양, 발적, 전신의 발진, 가려움, 복통, 구역, 구토 등의 증상이 나타나는 경우에는 이후 이 약과의 접촉을 피한다.

5. 상호작용

유사화합물(다른 세펨계 항생물질)과 푸로세미드 등의 이뇨제와 병용투여 시 신독성이 증가될 수 있으므로 신중히 투여한다.

6. 임부에 대한 투여

임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

7. 소아에 대한 투여

저체중출생아, 신생아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.

8. 임상검사치에의 영향

1) 테스테이프반응을 제외한 베네딕트시약, 펠링시약, 클리니테스트에 의한 요당검사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 주의한다.

2) 직접 쿰스시험 양성이 나타날 수 있으므로 주의한다.

9. 적용상의 주의

1) 이 약은 정맥주사로만 사용한다.

2) 정맥 내 대량 투여에 의해 드물게 혈관통, 혈전성 정맥염을 일으킬 수 있으므로 주사액의 조제, 주사부위, 주사방법 등에 대하여 충분히 주의하고 주사속도는 가능한 천천히 한다(정맥주사에 한함.).

3) 근육주사는 정맥주사가 곤란한 경우에만 사용한다.

4) 근육주사 할 경우에는 조직, 신경 등에 영향을 피하기 위하여 다음 사항을 주의한다(근육주사에 한함.).

(1) 근육주사는 부득이한 경우에만 필요 최소량을 사용한다. 또한 동일 부위에 반복주사하지 않는다.

(2) 신경주행부위를 피한다.

(3) 주사침을 주입할 때에 격통을 호소하든가 혈액의 역류를 보일 경우에는 곧 바로 침을 뽑고, 부위를 바꾸어 주사한다.

5) 용해 후에는 신속히 사용한다. 또한 부득이 보존을 필요로 하는 경우에도 8시간 이내에 사용한다. 이 경우 미황색 용액의 색깔이 시간이 경과됨에 따라 짙게 될 수가 있다.

10. 트랜스퍼장치(1회용시린지)가 장착된 경우의 용해조작법

1) 테두리의 접착상태를 확인한 후 블리스터를 개봉한다.

2) 바이알을 트랜스퍼장치의 투명한 통 안으로 "딸깍" 소리가 날 때까지 밀어 넣고, 바늘부분이 위로 향하도록 세로로 세운다.

3) 안전캡을 제거한다.

4) 트랜스퍼장치의 바늘 끝의 안전덮개가 있는 상태에서 백의 연결부위를 밀어 넣어 트랜스퍼장치와 백을 연결시킨다.

5) 바이알이 아래로 가도록 잡고, 바이알에 용해액이 반정도 찰 때까지 반복적으로 백을 여러번 쥔 후, 바이알을 가볍게 흔들어 용해한다.

6) 바이알을 위로 가도록 잡고, 백을 여러번 쥐어 바이알속의 용액이 백으로 이동되도록 한다. 바이알에 용해되지 않은 약이 남아 있을 경우에는 5) 및 6)의 조작을 반복한다.

7) 백으로부터 트랜스퍼장치를 제거하고, 안전캡을 다시 장착한 후 버린다. 혼합된 백을 흔들어 잘 섞이도록 한다.

(피내반응용)

1. 경고

앰플주사제는 용기 절단 시 유리파편이 혼합되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용 시 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 소아, 노약자 사용 시에는 각별히 주의한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약물에 의한 쇽의 병력이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1) 다른 세펨계(세팔로스포린계 및 세파마이신계) 또는 페니실린계 약물에 대해 과민반응의 병력이 있는 환자

2) 알레르기 증상을 일으키기 쉬운 체질을 가진 환자

4. 이상반응

드물게 쇽, 아나필락시양 증상을 일으킬 수 있으므로 충분히 관찰하고, 불쾌감, 구내이상감, 어지러움, 변의, 이명, 발한, 천명, 호흡곤란, 맥관부종, 전신홍조, 두드러기 등의 이상반응이 나타난 경우에는 적절한 처치를 한다.

5. 일반적 주의

1) 쇽 증상이 나타날 수 있으므로 알레르기에 관해서 충분히 문진을 한다.

2) 쇽 발생에 대비하여 구급처치 준비를 해두고 투여 후에도 환자를 안정한 상태에서 충분히 관찰한다.

3) 본 피내반응시험이 음성일 때에도 이 약물의 투여에 의한 쇽이 나타날 수 있다.

4) 이 약의 주사액 조제시에 쇽을 수반하는 접촉 두드러기가 나타날 수 있으므로 조제시 손의 종창 · 가려움, 발적, 전신의 발진 · 가려움, 복통, 구역, 구토 등의 증상이 나타났을 경우에는 이후에 이 약과의 접촉을 피한다.

6. 적용상의 주의

용해 후에는 빨리 사용하고 잔액은 폐기한다.